

Aplicabilidad de interdependencia y directorios

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Determinar requisitos propios del estándar y mantener medios de apoyo y remisión sin asumir convenios universales.

2. Alcance y condiciones de uso

Servicio de terapias: numerales 11.3.1.29 y 30 indican no aplica para interdependencia. Esto no elimina procedimientos de referencia, emergencia, continuidad ni contratos de calidad que se necesiten por otras actividades.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta	Identificar necesidad y urgencia y realizar entrega clínica.
Apoyo real	Gestionar comunicación y documentos sin alterar la decisión clínica.
Responsable de continuidad	Confirmar directorio, recepción y seguimiento posible.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Confirmar que la oferta real corresponde al servicio de terapias y modalidad registrada

Confirmar que la oferta real corresponde al servicio de terapias y modalidad registrada. Revisar si otros servicios ofertados tienen requisitos de interdependencia propios.

2. Documentar criterio específico de no aplicabilidad del estándar para terapias, separándolo

Documentar criterio específico de no aplicabilidad del estándar para terapias, separándolo de continuidad, reprocesamiento, urgencia y calidad. No copiar la justificación de psicología del checklist.

3. Identificar recursos y profesionales a los que se remite según necesidad: urgencias, medic

Identificar recursos y profesionales a los que se remite según necesidad: urgencias, medicina, fisiatría, ortopedia y otros. Psiquiatría y laboratorio no se agregan como convenios obligatorios universales por aparecer en una lista.

4. Verificar directorio con nombre de entidad, dirección, teléfono, servicio, horario y fecha

Verificar directorio con nombre de entidad, dirección, teléfono, servicio, horario y fecha de comprobación. Conservar canal alternativo y dirección de sede para facilitar apoyo urgente.

5. Cuando la actividad requiere un contrato o acuerdo, verificar alcance, calidad y vigencia

Cuando la actividad requiere un contrato o acuerdo, verificar alcance, calidad y vigencia. Un servicio de esterilización contratado necesita acuerdos y evaluación aunque interdependencia de terapias no aplique.

6. Revisar directorios y criterios al cambiar oferta

Revisar directorios y criterios al cambiar oferta. Dejar pendientes los contactos no probados y actualizar protocolos y formación.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

No aplica del estándar documentado con criterio.

Ruta de urgencia operativa.

Directorio verificado trimestralmente como regla local.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.7 y 11.3.1.29-30: para terapias el criterio específico indica no aplica. Se conserva referencia, emergencia y continuidad del 11.1.5.17; no imponer contratos de red universales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Servicio y modalidad	
Criterio de interdependencia	
Justificación	
Actividad relacionada	
Entidad y servicio	
Contacto y horario	
Fecha de comprobación	
Acuerdo cuando requerido	
Canal alternativo	
Seguimiento	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576